Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Igarassu

R TREZE, S/N, ao lado Ministério Público, CENTRO, IGARASSU - PE - CEP: 53610-715 - F:(81) 31819319

Processo nº **0001918-72.2024.8.17.2710**

AUTOR(A): B. P. D. S., JULIANA PAULA DE SANTANA SOUZA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE movida por BETINA PEREIRA DE SANTANA, menor, CPF de número 171.585.744-58, neste ato representado por sua genitora, JULIANA PAULA DE SANTANA SOUZA em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 63.554.067/0001-98, com sede na Av. Heráclito Graça, nº 406, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60140-061, igualmente qualificada, na qual aduz, em síntese, que é beneficiária do Plano de Saúde da Hapvida e que foi diagnosticada com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) nivel 2 de suporte – CID10 - F84.0/ CID 11: 6A02, necessitando de tratamento por meio de terapias especializada, conhecida como método ABA.

Relata que, conforme diagnóstico realizado pela médica neuropediatra Desirée Louise Procópio – CRM 26333, foram indicadas sessões semanais com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo, dentre outras especialidades, sob o argumento de que são imprescindíveis para uma melhor evolução e prognóstico da paciente e que o retardo ou redução do tratamento impactariam negativamente no desenvolvimento da criança.

Acrescentou que após o diagnóstico e prescrição, iniciou as tratativas administrativas junto ao plano de saúde demandado para conseguir o tratamento solicitado pela médica especialista, porém a parte ré só liberou e marcou algumas das terapias, não seguindo, portanto, o laudo.

Ao final pediu pela concessão da Tutela de Urgência com o fito de compelir a empresa Demandada a autorizar/custear a Requerente BETINA PEREIRA DE SANTANA todo o tratamento multidisciplinar prescritos pela neuropediatra e, no mérito, a confirmação daquela, com a condenação da parte requerida em danos morais.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID n. 166915260 a 166915277.

Decisão interlocutória a qual deferiu a tutela de urgência (ID. 167197844 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam)

Notícia de interposição de agravo de instrumento pelo demandado (ID 170031370 - (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam))

Instado a se contrapor aos substratos fático e jurídicos declinados na peça de ingresso, o demandado acostou aos autos a contestação de ID 169684787 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam).

Réplica à contestação (ID 170821105 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam))

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, pontue-se que a demanda em tela comporta julgamento antecipado (julgamento conforme o estado do processo), posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (art. 330, I, do Código de Processo Civil).

Analisando o álbum processual, afere-se que o demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir a demandada a autorizar o tratamento prescrito pela neuropediatra Desirée Louise Procópio – CRM 26333, necessário/imprescindível para o seu desenvolvimento e minimização dos efeitos decorrentes de seu diagnóstico, visto que é portadora do TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) nível 2 de suporte – CID10 - F84.0/ CID 11: 6A02.

Visando subsidiar os argumentos expendidos na peça atrial, trouxe à baila os elementos de ID n. 166915260 a 166915277.

Consoante outrora asseverado, a demandada, devidamente citada para angularizar a relação processual, deduziu a contestação de ID 169684787 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam). oportunidade em que defendeu, em sede de preliminar, o sobrestamento da ação sob o argumento de que o Acórdão do Incidente de Assunção de Competência nº 0534706-2, julgado pela Seção Cível do TJPE em 26/07/2022, não estaria estabilizado, razão pela qual sua aplicabilidade estaria prejudicada até o trânsito em julgado do referido acórdão.

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, alegando que nunca se opôs a prestar o tratamento multidisciplinar previsto no rol da ANS, que pode ser prestado por equipe multiprofissional conveniada.

Defendeu que não é exigido especialização para a escolha do método terapêutico para o Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, já que estes têm o direito à ampla autonomia e liberdade de convicção.

Ainda, que a Terapia ABA em ambiente domiciliar e escolar é uma exceção e tal excepcionalidade não se aplica ao caso dos autos, já que o tratamento pretendido é eletivo e que a Operadora de Saúde dispõe de rede credenciada composta por equipe multidisciplinar apta, não havendo que se falar no dever de reembolsar, portanto, e, por fim, que não há obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar ou escolar, em especial do Acompanhante Terapêutico – AT.

No que toca à *preliminar de sobrestamento*, entendo que não assiste razão o demandado, porquanto é consabido que tese jurídica fixada em IAC tem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, porquanto o CPC faz essa exigência. Por esta razão, fica afastada tal preliminar.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do mérito da questão posta.

Inicialmente, é de salientar que a demanda em tela subsume-se aos ditames da legislação consumerista, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 608, cujo teor assim se corporifica:

> Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

O vínculo jurídico-obrigacional entre as partes encontra-se devidamente comprovado, sendo certo que a autora é beneficiária do seguro de saúde demandado (ID 166915261,).

Nesse sentido, assevere-se o laudo médico de ID 166915271 subscrito pelo médica especialista Dra. Desirée Louise Procópio – CRM 26333, o qual ilustra esclarecimentos sobre o quadro clínico da autora e a imprescindibilidade de tratamento prescrito.

De outra banda, alega o demandado que não houve negativa e, ainda, que dispõe em sua rede credenciada de profissionais habilitados ao tratamento prescrito.

Ora, quanto à negativa, resta devidamente comprovado que apenas parte do protocolo prescrito pela neuropediatra foi autorizado.

Isso porque os atendimentos que o demandado comprova haver prestado ao autor, no que tange ao objeto da presente lide, restringe-se a apresentar telas de seu sistema referentes a marcação de CONSULTA/SESSAO COM FONOAUDIOLOGO, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA (ID 169684795 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam)) sem a comprovação da quantidade de vezes e horas semanais, nos termos prescritos pela médica especialista.

Neste sentido, vale dizer que a representante legal do autor confirma o atendimento na rede credenciada, contudo, de forma parcial no que toca aos tipos de terapia e em carga horária inferior.

No que se refere aos certificados acostados aos autos pelo demandando, a fim de comprovar a existência, em sua rede credenciada, de profissionais habilitados nas técnicas prescritas para atendimento do autor, é de se gizar que não obteve êxito em tal demonstração para afastamento do direito que visa o autor.

Isso porque sequer comprovou que tais pessoas são prestadoras de serviço do HAPVIDA e, mais que isso, não conseguiu comprovar se o plano possui, em sua rede credenciada, o tratamento **integralmente** prescrito.

Vê-se que os agendamentos mencionados não contemplam todas as modalidades de tratamento nem estão na frequência indicada no laudo (169684795 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam))

Ademais, no que tange aos tipos de terapia, quantidade de sessões e carga horária de atendimento prescritas pelo médico especialista, o qual é conhecedor do quando clínico do autor e a quem compete prescrever o tratamento necessário ao seu desenvolvimento, é de relevar que, malgrado o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS (*conforme decidido pela 4.ª Turma do STJ, no REsp. 1733013 e, posteriormente, em 08 de junho de 2022, pela 2.ª Seção do STJ, nos EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704*), a edição da Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022, que deu nova redação ao § 4º do art. 6º da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS, assim definiu as modalidades dos tratamentos prescritos para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista:

> "Art. 6º [...]
>
> § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Esta Resolução, que passou a ter vigência em 1º de julho, tornou inequívoco que o plano deve cobrir <u>todo e qualquer método indicado pelo médico para tratamento de autismo e seu espectro terapêuticos requeridos.</u>

Igualmente superada a questão do limite de sessões a serem cobertas pelo plano; pouco tempo depois da Resolução acima, a ANS publicou a Resolução nº 541, de 11 de julho de 2022, que retirou os limites de sessões de cobertura para atendimento com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização antes estabelecidas.

Tais resoluções, combinadas, conferem amplo e irrestrito acesso em espécies de tratamento e em quantidade de sessões às terapias disponíveis para os portadores de autismo e transtornos do espectro autista.

Com isso, qualquer discussão acerca da própria taxatividade do Rol da ANS resta esvaziada, porquanto o tratamento está inequivocamente inserido dentro da cobertura mínima a ser oferecida pelos planos.

No mesmo sentido, a Seção Cível do TJPE, no julgamento do IAC de autos n. 0018952-81.2019.8.17.9000, ocorrido em 26 de julho de 2022, fixou as seguintes teses, vinculantes no âmbito da Justiça Estadual:

> "Diante do tudo que foi explicitado, e, considerando a relevância social do tema, conforme é sabido por todos, e tão esperado pela sociedade brasileira, o meu voto é no sentido de acolher o IAC – Incidente de Assunção de Competência, em conformidade com as normas previstas no CPC e Regimento Interno da Corte, fixando as seguintes teses:
>
> Tese 1.0 – Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS nº 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar, à luz do disposto na Lei nº 12.764/2012 art. 3º, I, III e parágrafo único.
>
> Tese 1.1 – Os requisitos necessários para que o profissional de saúde seja considerado especialista nos métodos ABA (análise do comportamento aplicada), BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇAO SENSORIAL, de acordo com o art. 6º da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, deve estar conforme legislação específica sobre as profissões de saúde eregulamentação de seus respectivos conselhos profissionais.
>
> Tese 1.2 – Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.
>
> Tese 1.3 – O reembolso: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada do serviço de saúde na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-lo na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, na

hipótese em que, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento. Tese

1.4. - A negativa de custeio das terapias multidisciplinares de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista poderá ensejar reparação por danos morais, mesmo antes da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.

Tese 2.0 - As terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, quando aplicadas por profissionais da área de saúde, têm obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.

Tese 2.1 - Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar as terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, indicadas pelo médico assistente para tratar doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Tese 2.2 – O reembolso para as terapias especiais de cobertura obrigatória de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada da terapia na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-la na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.

Tese 2.3. - A negativa de custeio das terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista enseja reparação por danos morais, a partir da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, que as regulamentou."

(IAC n.° 0018952- 81.2019.8.17.9000, Seção Cível do TJPE, Relator Des. Tenório dos Santos, data do julgamento 26-07-2022).

E neste sentido continua decidindo:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais , S/N, 1º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0009630-19.2018.8.17.2001 APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, D. S. S. APELADO: D. S. S., HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EMENTA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS ESPECÍFICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TESES FIRMADAS EM IAC (INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA). CABIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. CUSTEIO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – Mantida a gratuidade da justiça. Embora relativa a presunção de hipossuficiência, inexistem circunstâncias nos autos que levem a crer ter havido qualquer alteração na condição financeira do menor a justificar o afastamento do benefício. 2 – Há nos autos criança portadora de TEA para quem foi prescrito tratamento multidisciplinar, tendo a empresa o dever de custear as despesas daí advindas, sob pena de frustrar a legítima expectativa do consumidor de receber o tratamento de que necessita, devendo ser obedecida a prescrição do médico. 3– No julgamento do EREsp 1.886.929, o STJ concluiu pela taxatividade (com exceções) da referida lista, e entendeu que o plano de saúde é obrigado a custear tratamento para portador de autismo, porquanto "a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol de saúde suplementar. 4 – O TJPE, no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0018952-81.2019.8.17.9000, concluiu pela responsabilidade dos planos de saúde pelas despesas com tratamento multidisciplinar e terapias especiais aplicadas a portadores de TEA, incluindo a hidroterapia e o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. 5 – Cabe à seguradora oferecer ao segurado atendimento com prestador apto a executar o método ou técnica indicados, suportando integralmente e sem as limitações da tabela as despesas realizadas em rede particular quando os credenciados não oferecem o serviço, sendo também esse o entendimento lançado no parecer ministerial. . 6 – No caso, há notícia de que o autor não tem conseguido na rede atendimento nos moldes prescritos, e embora a Hapvida tenha apresentado lista de profissionais acompanhadas de certificados, inexiste comprovação de que as prescrições médicas têm sido respeitadas quanto aos pormenores de cada uma das especialidades indicadas e no que se refere ao número e à duração das sessões. 7 – Destaca-se, portanto, a proteção constitucional à saúde e à vida e promove-se o devido respeito à dignidade da pessoa humana, às orientações da Lei nº 12.764/12 (que resguarda os direitos da pessoa portadora de TEA) e aos ditames do CDC, do qual se extrai a necessidade de buscar o equilíbrio da relação jurídica em questão. 8 – Configurada a conduta abusiva da parte ré ao não fornecer a cobertura para o tratamento nos moldes prescritos, mostrando-se induvidoso o cabimento de indenização por danos morais. Mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se ajusta às circunstâncias do caso, respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a

posição das partes, além de atentar para a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, não merecendo alteração. 9 –DESPROVIDO o recurso da Hapvida e PROVIDO o apelo de Davi para determinar que o custeio pela seguradora se dê de forma integral, ainda que o tratamento ocorra fora da rede credenciada, reservando-se o pedido de majoração das astreintes e bloqueio de valores para apreciação oportuna no 1º grau em fase de cumprimento de sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009630-19.2018.8.17.2001, os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade da ata de julgamento e nos termos do voto do Relator, acordam à unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Hapvida e DAR PROVIMENTO ao apelo de Davi para determinar que o custeio pela seguradora se dê de forma integral, ainda que o tratamento ocorra fora da rede credenciada. Recife, data conforme certificação digital. Desembargador Bartolomeu Bueno Relator ?(TJ-PE - AC: 00096301920188172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2023, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0046058-34.2017.8.17.2001 APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. M. R. B. D. O., JANAINA ALEXANDRE BARBOSA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO NOS MOLDES REQUERIDOS NO LAUDO MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. Cabe ao juízo de origem e ao tribunal a aplicação imediata das teses definidas no julgamento do IAC, a partir da publicação do acórdão paradigma como condição para a sua imediata aplicação, não havendo que condicioná-las ao trânsito em julgado do incidente; 2 – Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS nº 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar (...) (Tese 1.0 firmada no julgamento do IAC n. 18952-81.2019.8.17.9000, julgado em Ago/22, TJPE) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação cível nº 46058-34.2017.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Recife, data de sessão de julgamento Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto. (TJ-PE - Apelação Cível: 0046058-34.2017.8.17.2001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 11/12/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC).

Desta feta, vê-se que estas novidades regulatórias são enfáticas quanto à obrigatoriedade de cobertura da terapia multidisciplinar, sendo, portanto, abusiva a recusa do plano em proporcionar o tratamento de forma integral.

Nesse ínterim, resta incontroversa a obrigação do plano de saúde demandado de viabilizar o tratamento do autor, seja através dos profissionais habilitados integrantes de sua rede conveniada, ou, em não havendo, custear o tratamento em estabelecimento diverso, caso em que incide o disposto no art. 4º da RN nº 259, da ANS, que assegura ao paciente o custeio do tratamento fora da rede credenciada oferecida pela operadora de serviços de assistência à saúde **na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.**

No que toca à clínica, no entanto, entendo foge à alçada da magistratura indicar nominalmente os profissionais que devem ser pagos pelo plano, ainda mais quando eles estão fora da rede credenciada.

Nesse contexto, não pode haver direcionamento nesta decisão para profissionais específicos. Deve haver, portanto, a cobertura do tratamento por profissionais habilitados, mesmo fora da rede credenciada, de escolha do autor entre os especializados nos métodos necessários ao seu tratamento.

Assim, resta inafastável o reconhecimento à indisponibilidade do direito fundamental à saúde e à vida, elevados pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna.

No que tange aos danos morais, igual sorte detém o requerente, verificada a ilegalidade na conduta do demandado que deveria ter viabilizado o tratamento da parte autora, nos termos prescritos pelo médico que o acompanha, conforme já exposto e, sendo inquestionável o nexo causal, destaco que a recusa indevida da assistência, o que se deu no momento em que o paciente mais necessitava, representa afronta aos seus direitos de personalidade, pois, embora tenha contratado um seguro de saúde justamente para evitar quaisquer complicações no momento em que eventualmente se deparasse com uma situação delicada, viu-se impedido, injustificadamente, de usufruir de direitos previstos decorrentes do próprio contrato, para o qual contribuiu.

Trata-se de situação excepcional, que por certo ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando injustificada ofensa à integridade física e psíquica, impondo desnecessário e significativo sofrimento à parte demandante que não teve acesso ao tratamento indispensável.

Dessa feita, configurado o direito à compensação pelos danos morais, tem-se que, relativamente à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se para a extensão do dano, comportamento dos envolvidos, condições econômicas e sociais das partes e repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, evitando-se que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, ou que seja fixada em valor irrisório.

Diante do exposto e em consonância com os fundamentos explicitados, RESOLVO O MÉRITO, **consolidando a tutela de urgência deferida,** com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, para:

- DETERMINAR que a Demandada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. *(acima qualificada)*, sob pena de bloqueio de valores nas contas bancárias da demandada, **NO PRAZO DE VINTE QUATRO HORAS**, autorize/custeie à autora o tratamento prescrito *(laudo de* 166915271) pela médica especialista Desirée Louise Procópio – CRM 26333- Neuropediatra.

- CONDENAR a Demandada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar ao demandante, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (*dez mil reais*), a ser corrigido com base na tabela do ENCOGE, tendo-se por termo *a quo* a data da presente decisão (***Enunciados das Súmulas n. 362 e 160 do STJ e do TJPE, respectivamente***); cominando-se, ainda, juros de mora no percentual de 1% (*art. 406 do CC em vigor e a sua combinação com o art. 161, § 3º, do CTN*), tendo-se por termo inicial a data da citação.

- CONDENAR a demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes, por força do art. 85, §2º, I a IV, do novel Código de Processo Civil, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (*quinze*) dias (*a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil*), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Contador do Juízo a fim de que seja verificada a existência de custas processuais pendentes. Em havendo, intime-se a parte Devedora para o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 20% sobre o valor do débito, nos termos do Art.22, da Lei 17.116/2020.

No caso de inércia, remetam-se ao Comitê Gestor de Arrecadação/Procuradoria Geral do Estado, conforme seja o caso, a documentação listada no Art. 27, §3º, da Lei 17.116/2020, a fim de que sejam adotadas as providências que entender, inclusive o protesto do título judicial e à inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança judicial do débito.

Caso não conste nos autos os dados relativos ao CPF do Devedor, que torne possível a emissão de guia pelo SICAJUD, remetam-se ao arquivo.

Após, a adoção das medidas acima, remetam-se ao arquivo independentemente do transcurso de prazo processual.

Igarassu - PE, data e assinatura eletrônicas.

LECÍCIA SANT'ANNA DA COSTA - Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LECICIA SANT ANNA DA COSTA
23/07/2024 20:28:14
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 176636515

24072320281398300000172397625

IMPRIMIR GERAR PDF